

Cycle de Préparation à l'Examen Classant National

Arrêt Cardiorespiratoire

Pr. Hamdi BOUBAKER

QCM :

La dépolarisation ventriculaire se manifeste sur l'ECG par :

- A. L'onde P
- B. Le complexe QRS
- C. L'intervalle QT
- D. L'intervalle PR
- E. Le segment ST

QCM :

L'espace PR :

- A. Correspond à la propagation de la dépolarisation au niveau du nœud auriculo-ventriculaire
- B. A normalement une durée supérieure à 0,12s
- C. Correspond à la dépolarisation totale des oreillettes
- D. Es normalement isoélectrique
- E. Est également appelé intervalle PR

Le diagnostic de l'arrêt cardio circulatoire :

- a. Est clinique
- b. Est établi grâce à l'ECG
- c. L'absence de respiration est vérifiée pendant 20 secondes
- d. Le gasping est une respiration agonique
- e. Le pouls est vérifié au niveau radial

Le diagnostic de l'arrêt cardio circulatoire :

- a. La respiration est vérifiée après la libération des voies aériennes
- b. Est défini par l'asystolie au scope
- c. Le pouls chez l'adulte est vérifié au niveau carotidien
- d. Le pouls chez l'adulte est vérifié au niveau pédieux
- e. La mydriase bilatérale est constante

Conséquences de l'anoxie post ACR :

- a. Le tissu cérébral est le plus vulnérable à l'anoxie
- b. Le métabolisme aérobie est stimulé
- c. L'acidose entretient une décharge catécholaminergique
- d. Une vacuolisation cytoplasmique
- e. La réponse inflammatoire est accrue

Au cours de la reperfusion post arrêt cardiaque :

- a. A l'échelle cellulaire il y a une formation de radicaux libres
- b. Les radicaux libres pérennisent la réponse inflammatoire
- c. Les radicaux libres entraînent des lésions cellulaires
- d. Les membranes cellulaires sont épargnées des lésions
- e. La perméabilité vasculaire est altérée

Concernant le cœur après récupération :

- a. La défaillance myocardique participe majoritairement au choc
- b. La sidération myocardique est une forme d'autoprotection contre la dette en O₂
- c. Dans l'hibernation myocardique, l'hypo contractilité est réversible
- d. Les arythmies ventriculaires sont fréquentes
- e. Les arythmies auriculaires peuvent être observées.

Dans le syndrome post arrêt cardiaque :

- a. Les lésions anoxo ischémiques sont immédiatement évaluées après récupération
- b. L'œdème cérébral est aggravé par la reperfusion
- c. Les anomalies de la coagulation sont fréquentes
- d. Une insuffisance surrénalienne relative peut être observée
- e. La défaillance multi viscérale est constante

Les causes cardiaques de l'ACR :

- a. Prédominant chez l'adulte (80% des ACR)
- b. Sont moins fréquentes que les causes respiratoires
- c. Les Syndromes coronariens aigus exposent aux arythmies ventriculaires
- d. La tamponnade est une cause réversible
- e. Sont souvent responsables d'une activité électrique sans pouls

Parmi les causes réversibles on distingue :

- a. L'hypoxie
- b. La bradycardie
- c. L'hypovolémie
- d. L'hyperthermie
- e. L'hyperkaliémie

Parmi les causes réversibles on distingue :

- a. La tamponnade
- b. L'infarctus du myocarde
- c. L'embolie pulmonaire
- d. Les intoxications
- e. La tachycardie supra-ventriculaire

La fibrillation ventriculaire :

- a. Est une activité régulière à complexes variables
- b. Peut être compatible avec un débit cardiaque
- c. Peut être causée par un Syndrome coronarien aigu
- d. N'indique pas un CEE
- e. Indique le massage cardiaque externe

La tachycardie ventriculaire :

- a. Est souvent régulière
- b. Peut être polymorphe
- c. Peut être ou non compatible avec des signes de vie
- d. Est traitée d'emblée par l'adrénaline
- e. A une fréquence de 100 à 300/min

L'asystolie :

- a. Est une ligne parfaitement horizontale
- b. L'activité auriculaire peut persister
- c. Est traitée par CEE
- d. Est de bon pronostic
- e. Peut être confondue avec une FV à très petites mailles

L'activité électrique sans pouls (AESP) :

- a. Peut être de fréquence élevée
- b. Peut être de fréquence lente
- c. Est de bon pronostic quand elle est causée par un SCA
- d. Est généralement le rythme d'AC causé par une hypovolémie
- e. Indique l'injection d'amiodarone

Concernant le concept de la chaîne de survie

- a. Résume les actions successives dès la reconnaissance jusqu'à la RCP spécialisée
- b. L'alerte doit être précoce
- c. La ventilation bouche à bouche est priorisée par rapport au MCE
- d. La défibrillation ne doit être faite que par l'équipe spécialisée
- e. Des signes d'alerte imposent l'appel précoce du SAMU

Le massage cardiaque externe :

- a. Doit être effectué avec un rythme de 60/min
- b. Doit être effectué avec une profondeur de 5 à 6 cm
- c. Doit être commencé chez tout patient inconscient
- d. Doit être arrêté si le patient présente des signes de vie
- e. Doit être arrêté devant une tachycardie au scope

Le défibrillateur automatisé externe :

- a. Ne peut être utilisé que par un médecin
- b. Doit être manipulé en toute sécurité
- c. Utilise 3 électrodes
- d. Interprète le rythme immédiatement après la défibrillation
- e. A amélioré le pronostic des patients victimes d'AC

Vous arrivez 4 minutes après AC chez une femme de 70 kg. Un accès veineux est en place.

Le moniteur confirme une asystolie. 2 infirmiers effectuent une RCP de manière efficace.

Vous recommanderiez :

- a. L'administration d'un choc à 200 J
- b. L'injection de bicarbonate de sodium 500 mmol IV
- c. L'injection d'adrénaline 1 mg en IV
- d. L'injection d'amiodarone 150 mg
- e. Aucun médicament

Au cours de la RCP spécialisée :

- a. 1 mg d'adrénaline doit être donnée à tous les patient en AC
- b. 100 mg de lidocaïne est le traitement de choix des patients en TV
- c. L'adénosine est efficace dans le traitement de l'AESP
- d. La dose initiale de l'amiodarone en cas de FV réfractaire est de 300 mg en IV
- e. Le monitoring cardiaque est continu

Au cours de la RCP spécialisée :

- a. L'évaluation de rythme se fait par les palettes ou avec les électrodes adhésives
- b. L'évaluation du rythme est indiquée toutes les minutes
- c. La défibrillation est délivrée avec une énergie de 200 J avec un défibrillateur monophasique
- d. La défibrillation est délivrée avec une énergie de 200 par un défibrillateur biphasique
- e. La défibrillation est pratiquée en mode synchrone

Au cours de la RCP spécialisée :

- a. L'intubation est le premier geste à pratiquer
- b. La ventilation à l'insufflateur manuel suffit au démarrage de la RCP
- c. L'utilisation d'un dispositif supraglottique est possible
- d. La ventilation au ballon se fait avec un rythme de 30/2
- e. Après l'intubation la ventilation se fait en continue à 10 /min

L'AC provoqué par hyperkaliémie :

- a. Peut se voir chez un insuffisant rénal
- b. Est traité par le sulfate de magnésium
- c. Le bicarbonate de sodium molaire est indiqué
- d. Le chlorure de calcium n'est pas indiqué
- e. Le massage cardiaque externe est indiqué

En cas d'hypothermie compliquée d'AC

- a. le réchauffement est indiqué
- b. La réanimation doit être prolongée
- c. Les doses de médicaments doivent être doublées entre 30 et 35°C
- d. La défibrillation n'est pas indiquée
- e. La mydriase signe la mort

La prise en charge d'un patient en FV comprend :

- a. Digoxine 0.5 mg
- b. 1 mg d'adrénaline après chaque choc
- c. 3 mg d'atropine après 2 boucles de RCP
- d. Un choc biphasique à 200 mg
- e. Amiodarone 300 mg Iv après le 3ème choc

Cas particuliers d'AC

- a. L'angioplastie est indiquée dès la récupération devant un SCA
- b. La thrombolyse est indiquée dans un contexte d'embolie pulmonaire
- c. Le sulfate de magnésium est indiqué devant une acidose
- d. L'intubation est indiquée dans un contexte de noyade
- e. L'exsufflation à l'aiguille est indiquée devant un pneumothorax

L'amiodarone

- a. Est un anti arythmique
- b. Ralentit la conduction auriculo-ventriculaire
- c. A un effet inotrope positif et vasoconstricteur
- d. La 2^{ème} dose indiquée devant un AC est de 450 mg si FV ou TV persiste
- e. Peut être remplacé par la vasopressine

L'adrénaline

- a. A un effet α puissant qui augmente l'inotropisme cardiaque
- b. Est un puissant vasoconstricteur
- c. Augmente les pressions de perfusion coronaire et cérébrale
- d. La dose initiale est 2 mg devant une asystolie
- e. Augmente la consommation d'O₂ par le myocarde

Le magnésium

- a. Est indiqué devant une torsade de pointe
- b. Est indiqué devant une toxicité à la digoxine associée à une hypomagnésémie
- c. Est indiqué à la dose de 5 gr en IV devant une TV polymorphe
- d. Diminue la libération d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice
- e. Est vasoconstricteur puissant

Le calcium est indiqué pour :

- a. La TV sans pouls causée par l'hyperkaliémie
- b. l'hyperkaliémie
- c. l'intoxication digitalique
- d. l'intoxication aux inhibiteurs calciques
- e. l'hypocalcémie

Le bicarbonate de sodium molaire

- a. A un effet inotrope positif
- b. Aggrave l'acidose intracellulaire
- c. Est indiqué dans l'AC causé par l'hyperkaliémie
- d. Est indiqué dans l'AC causé par l'intoxication aux anti-dépresseurs tricycliques
- e. Est administré simultanément par la même voie avec le calcium

Le remplissage vasculaire au cours de la RCP :

- a. Est indiqué dans un contexte d'hypovolémie
- b. Les colloïdes sont préférés aux cristalloïdes
- c. Le sérum glucosé est indiqué pour améliorer la récupération neurologique
- d. Le sérum salé isotonique (0.9%) est la meilleure solution
- e. Le bicarbonate de sodium à 1.4 % est la meilleure solution

Cas clinique N°1 :

Vous travaillez au service d'accueil des urgences, l'infirmière vous appelle pour un patient âgé de 60 an admis pou douleur thoracique avec une sensation de gêne respiratoire qui a comme antécédents un infarctus du myocarde remontant à 1 an. Elle l'a mis sous O2 au MHC

Dés votre arrivée, le patient présente un gasp agonique, le scope affiche ce tracé :



1. Quelle est votre conduite à tenir ?

.....

.....

.....

.....

.....

Après 8 minutes de réanimation, le patient récupère une activité circulatoire.

2. Quelle serait la cause la plus probable de son arrêt cardiaque ? Justifiez ?

.....

.....

.....

3. Quelle est votre conduite à tenir près la récupération ?

.....

.....

.....

Cas clinique N°2 :

Un homme de 75 ans a eu une gastrectomie partielle suite à un ulcère gastrique hémorragique. 2 heures après son retour du bloc au service de chirurgie, son abdomen est distendu

A l'examen clinique :

- Voies aériennes libres : FR à 30, SpO2 imprenable sous O2
- FC à 140, pouls fémoral faible, TA à 60/40 mmHg
- GCS à 12, pupilles réactives et symétriques, très pale

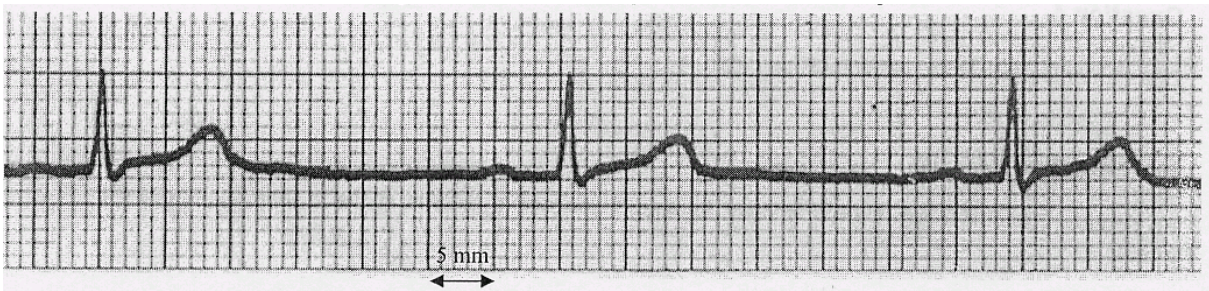
1. Quelle est votre conduite à tenir ?

.....

.....

.....

Au bout de 2 minutes il perd conscience et ne respire plus, il n'a plus de pouls. Le scope affiche ce tracé :



2. Quelle est votre conduite à tenir ?

.....

.....

.....

.....

.....